

表 1 主な肺間葉系腫瘍と特徴

疾患	概念と特徴
Pulmonary hamartoma	少なくとも 2 つ以上の間葉系組織（軟骨、脂肪、平滑筋など）よりなり、呼吸器上皮組織を巻き込む。t(3;12) 転座による <i>HMG2-LPP</i> 融合遺伝子を高率に認める。増殖は遅く、転移や切除後の再発はほとんど認めない。
Pulmonary chondroma	多くは Carney の 3 徴（胃平滑筋肉腫または GIST、肺軟骨腫、副腎外傍神経節腫）の部分症として若年（通常は 30 歳未満）女性にみられるが、まれに孤発例が主に男性にみられる。6 番染色体の過剰や 1q 欠失が報告されている。良性で死亡例、転移例の報告はない。
PEComatous tumors	血管周囲類上皮細胞由来であり、リンパ管管筋腫症などを中心とした疾患概念。詳細は本書各論 13. B を参照。
Inflammatory myofibroblastic tumor	紡錘形の筋線維芽細胞由来腫瘍で、形質細胞、リンパ球を含む炎症細胞浸潤を伴う。小児から成人まで認められる希少疾患。増殖は遅いが完全切除がなされなければ再発・転移を生じる。約半数で <i>ALK</i> 融合遺伝子を認め、特に小児・若年者で頻度が高い。 <i>ALK</i> 阻害薬が奏効する。
Epithelioid hemangioendothelioma	低～中等度悪性の血管腫瘍。肺、肝を中心に多臓器に病変を認めることが多く、この場合、原発巣の同定は困難である。肺病変は境界明瞭な単発あるいは多発結節となり他臓器がんの肺転移との鑑別が問題となる。t(1;3) による <i>WWTR1-CAMTA1</i> 融合遺伝子、 <i>YAP1-TFE3</i> 融合遺伝子などを認める。
Synovial sarcoma	肺を原発とすることが多い軟部肉腫であり、t(X;18)(p11.2;q11.2) による <i>SS18 (SYT)</i> を含む融合遺伝子が特徴的である。
Pulmonary artery intimal sarcoma	近位部肺動脈内膜より生じる。未分化で骨肉腫、軟骨肉腫成分を混じる。臨床的には肺血栓塞栓症との鑑別が重要になる。ほとんどの症例で <i>MDM2</i> 増幅。さらに多くの症例で <i>PDGFRA</i> 増幅を伴う。
Primary pulmonary myxoid sarcoma with <i>EWSR1-CREB1</i> fusion	比較的中枢の気管支に発生し、肺門腫瘍として認められる。喫煙者であることが多い。 <i>EWSR1-CREB1</i> 融合遺伝子を認める。低悪性度であり切除により長期無再発が得られる。

Advanced

■肉腫の治療

手術適応のある軟部肉腫に対しては、根治目的に、手術単独または手術と化学療法や放射線治療を組み合わせた集学的治療が行われる。進行・転移例の一次治療としては doxorubicin（腫瘍縮小による臨床的ベネフィットが期待される場合には ifosfamide と併用）、二次治療としては, eribulin, pazopanib, trabectedin などが標準治療となる。

文 献

- 1) WHO Classification of Tumours Editorial Board : Thoracic Tumours. WHO classification of tumors, 5th Ed, IARC, 2021